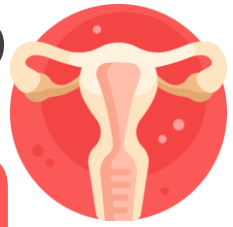
2025/09

Gynecology/Obstetrics

PGY&Clerk Orientation



林口長庚婦產部 **CR**

Outlines

- 次專科介紹
- 本月總醫師
- 教學分組表
- 婦產科樓層範圍
- 學術活動
- **Daily activity**
- 值班
- 接新病人實用技能
- 婦產科常見疾病及手術

次專科主治醫師、Fellow、NP

Obstetrics	Infertility	Oncology		Endoscope	Urogynecology
闕河晏 主任	張嘉琳 主任	趙安琪 主任		吳凱筠 主任	林益豪 主任
張舜智 趙安祥 詹耀龍 彭秀慧 李彥璋 江啟源 許晉婕	宋永魁 黃泓淵 吳憲銘 黃尚玉 徐樂天 白欣玉 劉尚旻 蔡天琦	賴瓊慧 張廷彰 黃寬仁 周宏學 林政道 黃慧君 陳敏煜	湯雲心 陳威君 董秀容 張淑涵 張宸邡	李奇龍 顏志峰 王錦榮 黃怡婷 翁　瑄 林杰進	梁景忠 盧佳序 謝梓翔 楊佳璇 周怡君
F 張芳瑜 F 李佳樺F 林宜萱 F陳 冰　F林芷嫻 NP 柳素貞 NP 洪子娟 NP 江中鳳	F 李艾倫 F 胡惇綦 F 羅雅薰 NP 胡美連	F 陸千琦 F 許卓皓 F 唐維鈞 F 鄭淨涵 F 李若瑜 F林美君 NP 陳雅惠 NP 劉美玲		F 林杰進 F 陳欣儀 F 王貞棣 NP 李佩珊	F 游千千 F 羅艾琳 F陳昱綺 F 林芳秀 F 林建棟 NP 柯逸貞

本月總醫師

學術CR	祝筱涵 39019	病房5,6K,13L 二線、學術活動
刀房控台CR	胡家瑜 89077	刀房學習、值班表、教學分組表
產房CR	吳家昀 53737	產房學習
Oncology CR	林青樺 15860	病房9,10,11K 二線
Infertility CR	郭常靜 18070	
Urology CR	祝筱涵 39019	
Scope CR	郭常靜 18070	

教學分組表

[林青樺-張景棣、江竺宣]

次專	VS	R/PGY		Clerk 2		Clerk 1			
		1-15	16-31	11/3-14	11/17-28	11/3-7	11/10-14	11/17-21	11/24-28
婦癌	賴瓊慧 25 65883 (21-23 假: 董秀容)	R3 張景棣 16283 3,14 PM off-王柏鈞 23180 11,17,25 PM off-陳昱成 18622 F1 李若瑜 89506				C1 歐柏儀 66947		C1 廖祥羽 66910	
	張廷彰 13 65882 (7,15-18 假:張宸邠)	Y1 陳念琪 89252 4,7,10 Day off-王柏鈞 23180 F1 林美君 89565	Y1 洪晧宸 65397 21,26 Day off-張恆翊 18356	C2 麥恩嘉 66884					C1 王致中 67032
	黃寬仁(基) 1 65887 (1-2 假: 張淑涵)	急診 R1 林昱廷 15192 5,12 PM off-王柏鈞 23180					C1 林新淳 67288		C1 林資穎 66687
	周宏學 23 65885 (25-28 假:張淑涵)	Y1 吳哲昇 53791 F2 鄭淨涵 89326	Y1 李修明 16772		C2 陳毓理 67136		C1 吳品萱 67019		
	林政道 45 65886	Y1 王柏鈞 23180 11 Day off-陳念琪 89252	Y1 王博奕 23299 17 off-張恆翊 18356 19,27 Day off-王柏鈞 23180 24 特休-洪智昱 53754			C1 葉宜綸 67168		C1 陳羽捷 66796	

婦產科樓層範圍

13L	尊爵病房	
12K	生殖中心 (取卵、門診)	第二簡報室 (右)、第三會議室 (左)
11K	護理站、子宮鏡檢查室	11K討論室
10K	護理站	
09K	護理站	09K交誼廳
09J	羊水檢查室、開刀房入口	
06K	護理站	06K討論室
05K	護理站	05K討論室
03K	產房	
02K	門診區、超音波檢查室	
KB2	婦產部辦公室	KB2討論室、LB2階梯教室

值班室密碼

值班室	人員	密碼
3K產房女值班室	女Fellow、CR	
3K產房男值班室	男Fellow、CR	
5K值班室(5K15)	女PGY2, R	
5K男值班室(小)	男PGY2, R	
6K值班室	男PGY1、Clerk2	
9K值班室	女VS	2072
10K男值班室	男PGY1、Clerk2	8251
11K女值班室	女PGY1、Clerk2	6567

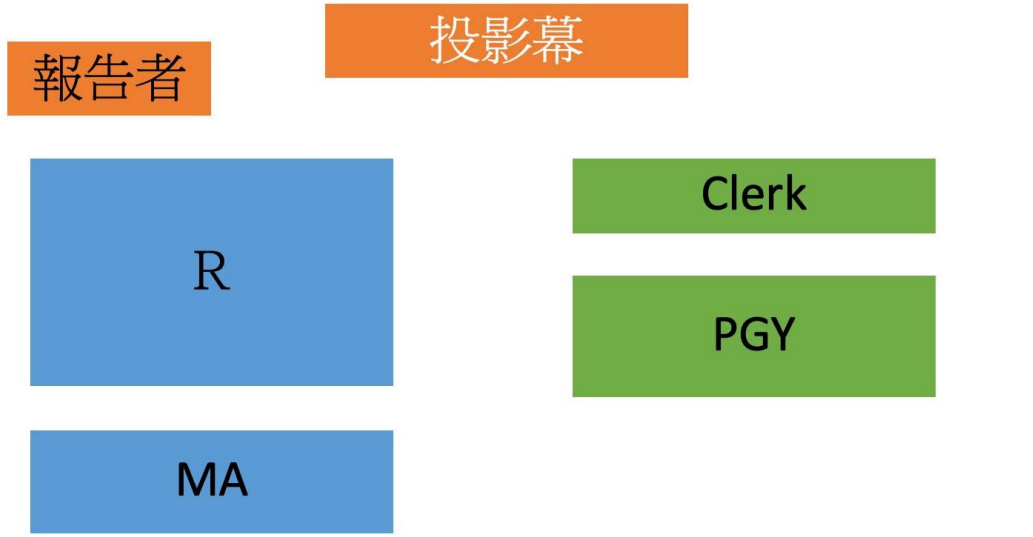
婦產部學術活動 (晨會)

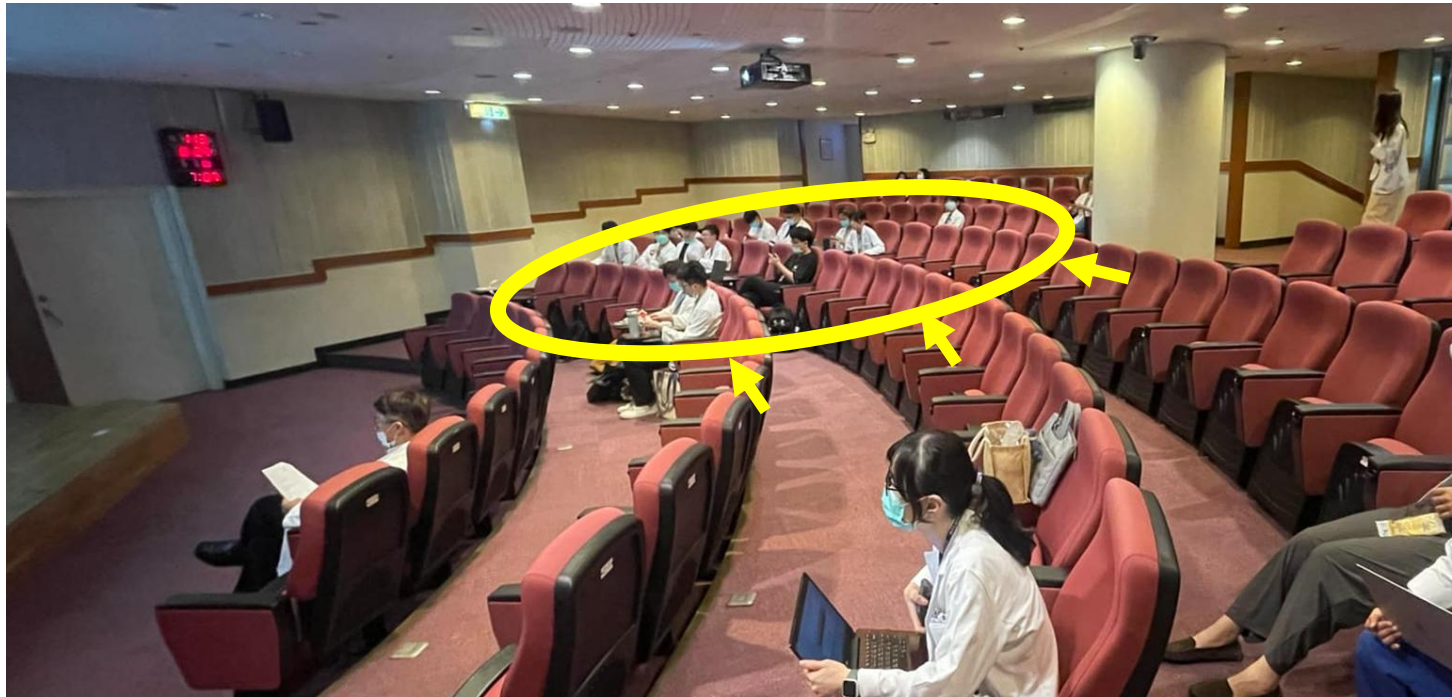
W1	Clerk Teaching round PGY Teaching round
W2	Clerk 核心課程 CR teaching Scope Meeting
W3	Uro Meeting Infertility Meeting
W4	**全科Meeting**
W5	Obstetrics Meeting Oncology Meeting 全院演講

務必準時參加！
記得簽到！

全科晨會注意事項

- 準時抵達
- 記得簽到，請勿代簽
- 坐在面對講台右側區域，PGY 第2~6排
- 有早餐





PGY: Daily Activity

- 上班時間：07:00-17:00
- 工作/學習內容：
  - 晨會、教學住診
  - 跟當科主治醫師查房、primary care病人
  - 刀房：參與當科主治醫師手術、支援其他手術助手 (控台CR調度)
  - 病房：病房留守
  - 產房：剖腹產手術第二助手
  - 教學門診 (準時出席！)、子宮頸抹片
- 上工第一天，請主動打電話給主治醫師自我介紹打招呼哦

當科Primary Care

- 跟主治醫師或NP確認查房時間，確實處理order
- 病歷要準時完成，下班前若有特殊病人要確實交班 (儘量16:30前完成)
- 接新病人：
  - 16:30 前由當科接病人(以護理紀錄病患報到時間為準)
  - Order + admission note + pre-OP note (預開刀病人)
- PGY值班隔天day off：
  - 下班之前要看過自己的病人
  - 維持良好照護品質及病人安全，請與cover的人交班完每個病人及交代要做的事 (Plan)、打完note 再下班
- 照護病人床數上限：clerk 1 (1-5床)/clerk 2 (2-6床)/ PGY 1 (14床)
- 照護病人若有問題可先請教同次專之R、CR、Fellow、NP，並與主治醫師討論

刀房學習、教學門診 (PGY)

A	B	C	D	E
陳念琪 89252	楊紹宇 18352	陳昱成 18622	洪晧宸 65397	李修明 16772
F	G	H	I	J
何沁蓁 19021	張恆翊 18356	王博奕 23299	李柏謬 15932	吳哲昇 53754
K	L	M	N	O
王柏鈞 23180	吳岱儒 23306	洪智昱 53754	急診 R1 林昱廷 15192	家醫 R1 吳宏庚 15251

PGY 刀房/產房學習

※ A2 順序：當科 clerk ➔ clerk2/1 刀房學習 ➔ 當科 PGY ➔ 刀房學習 PGY

一	二	三	四	五
11/03	11/04	11/05	11/06	11/07
BCLNM	DHKLNM	EKGAM	HKNLM	FCBHL
11/10	11/11	11/12	11/13	11/14
DNILM	GDANL	KFMG	HKINA	CEDIL
11/17	11/18	11/19	11/20	11/21
KDOB	HGFDB	MICFD	CIKG	JKG
11/24	11/25	11/26	11/27	11/28
IB	KCAGF	LICF	CADG	HKJGB

子宮頸抹片診 (PGY)

- 醫學大樓一樓，影像科照Xray的地方，直走到底，婦女醫學...走進去

抹片學習

一	二	三	四	五
11/03	11/04	11/05	11/06	11/07
陳昱成 18622	急診 R1 林昱廷 15192	王柏鈞 23180	楊紹宇 18352	王博奕 23299
11/10	11/11	11/12	11/13	11/14
李柏謬 15932	陳念琪 89252	何沁蓁 19021	洪智昱 53754	李修明 16772
11/17	11/18	11/19	11/20	11/21
王柏鈞 23180	家醫 R1 吳宏庚 15251	陳昱成 18622	陳念琪 89252	王柏鈞 23180
11/24	11/25	11/26	11/27	11/28
吳岱儒 23306	張恆翊 18356	急診 R1 林昱廷 15192	洪晧宸 65397	吳哲昇 53754

病房留守 (PGY)

- 工作範圍：
  - 當科在上刀時，協助處理病房complaint及order
  - 接新病人：
    - 無當科R/PGY、或當科為產房R (標註產房勿call)：Order + admission note + pre-OP note
    - 當科在上刀或處理其他專科業務：Order即可
- 處理order時間到17:00、接 new patient 時間到16:30

病房留守表

	一	二	三	四	五
	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7
5,6K留守	D	C	F	E	D
9K 留守	K	B	H	I	G
10K+13L 留守	E	F	I	C	N
11K+10A 留守	A	G	L	B	M
	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14
5,6K留守	C	F	I	B	K
9K 留守	B	C	H	C	G
10K+13L 留守	H	I	D	E	N
11K+10A 留守	K	M	L	F	A
	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21
5,6K留守	J	L	L	M	A
9K 留守	G	A	H	J	I
10K+13L 留守	I	J	A	D	B
11K+10A 留守	C	M	K	F	E
	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28
5,6K留守	G	B	M	J	A
9K 留守	F	D	H	I	C
10K+13L 留守	M	J	G	L	F
11K+10A 留守	L	H	E	B	D

PGY/R

A：陳念琪89252

B：楊紹宇18352

C：陳昱成18622

D：洪晧宸65397

E：李修明16772

F：何沁蓁19021

G：張恆翊18356

H：王博奕23299

I：李柏諺15932

J：吳晢昇53754

K：王柏鈞23180

L：吳岱儒23306

M：洪智昱53754

N：急診R1 林昱廷15192

O：家醫R1 吳宏庚15251

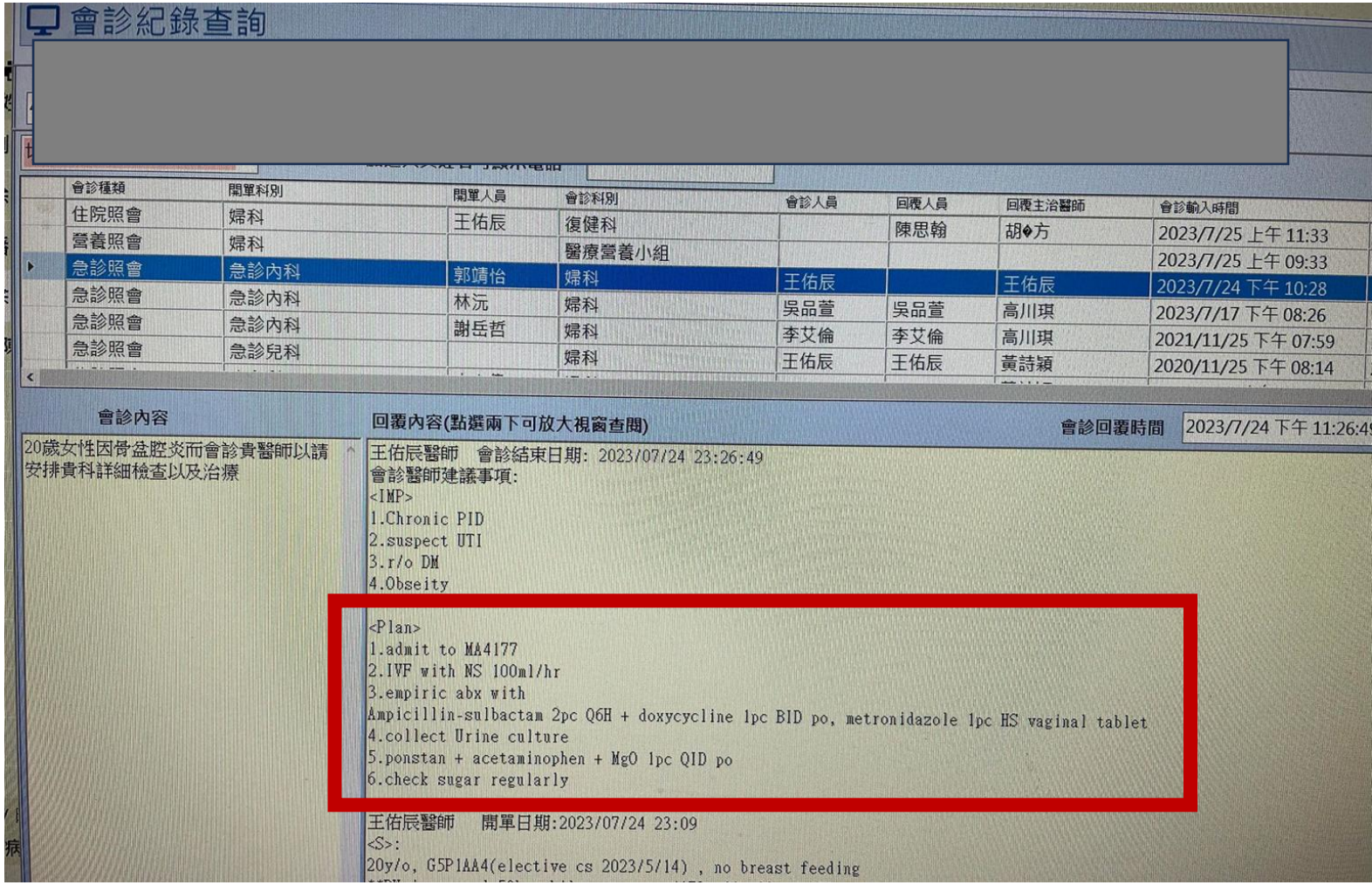
PGY值班

- 接新病人：
  - 值班接新病人上限: PGY 1 (平日10床，假日15床)
    如超過上限請告知值班CR，CR會依狀況調配支援
  - 平日班：16:30後新病人 (以護理紀錄病患報到時間為準) / 假日班：08:00
- PGY值班區域：
  - P1: 9K
  - P3: 10K
  - P4: 11K
  - L7: 6+9K
- 當天值班CR有權利視情況調度人力，幫忙其他病房事務或上急診刀
- 請勿任意換班

婦産科快速上手
臨床作業及基本知識

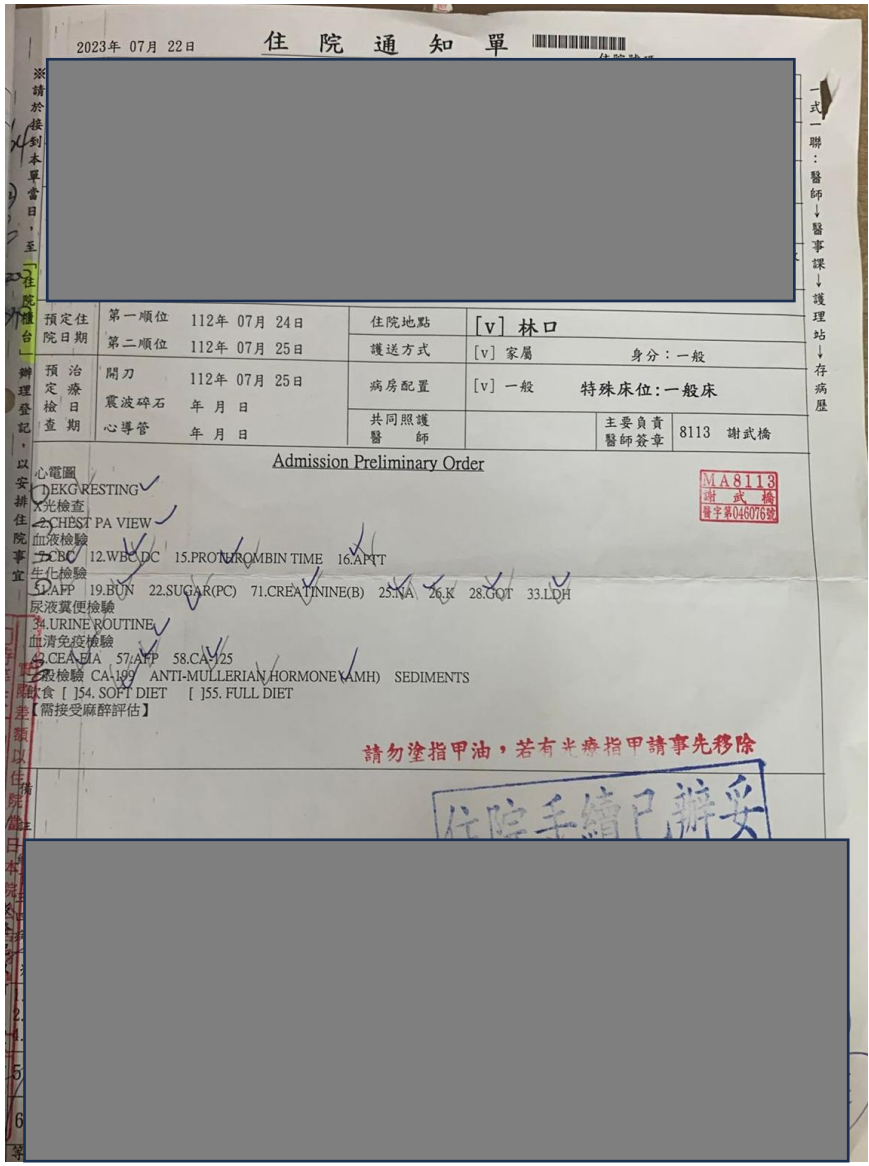
接新病人：急診入院

- 參考會診回覆



接新病人：化療

- 參考住院通知單及門診紀錄
  - Lab 項目有圈起來代表已在住服中心抽過血
- 完成 Order + admission note
  - Side effect？ (上次打完回家有什麼不舒服)
  - Pancytopenia？ (看回診跟入院lab data)
  - 第幾次Chemo、打什麼藥物？(住院病歷→ 化療藥歷)
- 化療order：專科護理師或CR會開
- 化療處置單：依照化療時間選-M為結尾的處置單


2023年 07月 22日 住 院 通 知 單

[redacted]

預定住院日期 第一順位 112年 07月 24日 住院地點 [v] 林口
第二順位 112年 07月 25日 護送方式 [v] 家屬 身分：一般
預治定檢查期 開刀 112年 07月 25日 病房配置 [v] 一般 特殊床位：一般床
震波碎石 年 月 日
心導管 年 月 日
共同照護醫師 主要負責醫師簽章 8113 謝武橋

Admission Preliminary Order

MA8113 謝武橋 醫字第046076號

心電圖
1.EKG RESTING
X光檢查
2.CHEST PA VIEW
血液檢驗
7.CBC 12.WBC DC 15.PROTHROMBIN TIME 16.APTT
生化檢驗
17.AFP 19.BUN 22.SUGAR(PC) 71.CREATININE(B) 25.NA 26.K 28.GOT 33.LDH
尿液糞便檢驗
34.URINE ROUTINE
血清免疫檢驗
42.CEA-EIA 57.AFP 58.CA-125
腫瘤檢驗 CA-199 ANTI-MULLERIAN HORMONE (AMH) SEDIMENTS
飲食 [ ]54. SOFT DIET [ ]55. FULL DIET
【需接受麻醉評估】

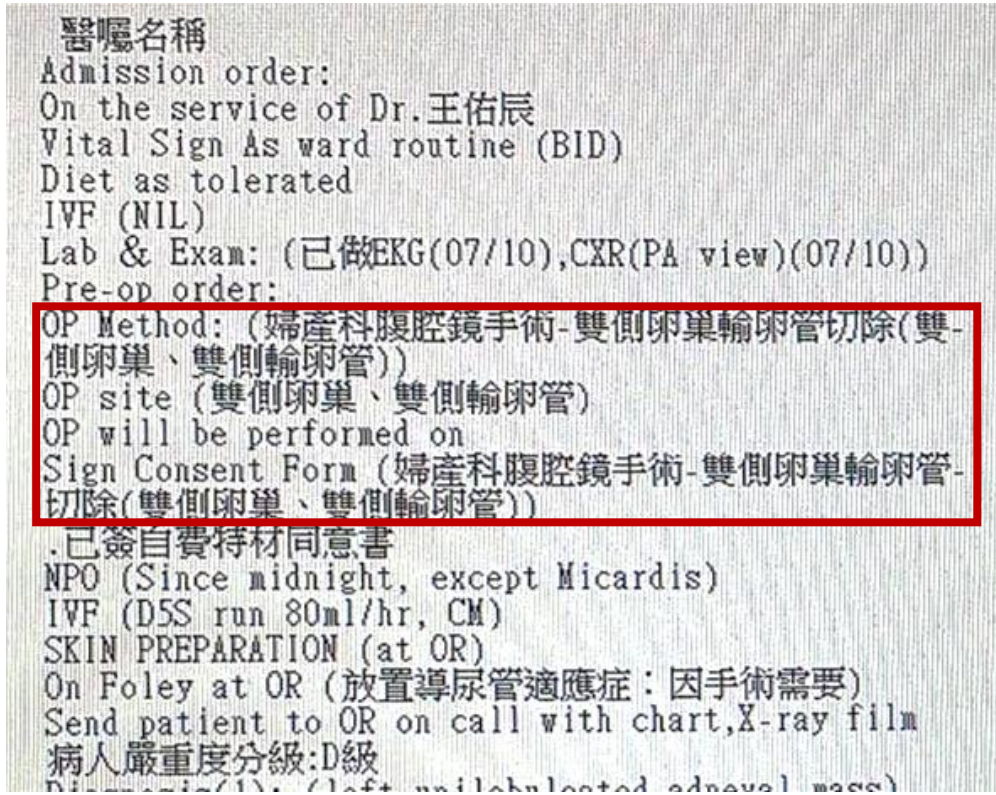
請勿塗指甲油，若有光療指甲請事先移除

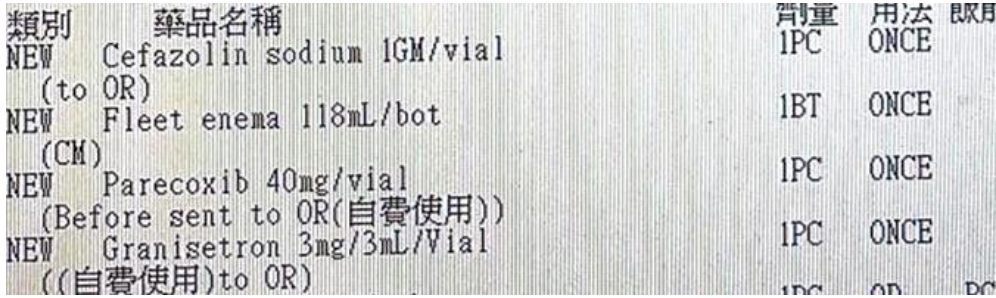
住院手續已辦妥

[redacted]

接新病人：婦科手術

- 參考住院通知單、門診紀錄、手術排程
  - Lab 項目有圈起來代表已在住服中心抽過血
- 完成 Order + admission note + Pre-OP Note
  - 醫藥囑本科或他科範本 → 4720 產科範本 → B01-Laparoscopy → Admission order
  - OP method/ Sign consent form : 需與同意書上一字不差
  - Pre-op order及自費特材各MA 不同，請參考「林口婦產科工作規範」
  - 要開婦科手術但月經超過一個月沒來的未停經女性請務必驗孕
  - Cytotec (Misoprostol)一定要開自費+同意書！(如果開錯要告訴書記，不是刪掉就好!)


醫囑名稱
Admission order:
On the service of Dr.王佑辰
Vital Sign As ward routine (BID)
Diet as tolerated
IVF (NIL)
Lab & Exam: (已做EKG(07/10),CXR(PA view)(07/10))
Pre-op order:
OP Method: (婦產科腹腔鏡手術-雙側卵巢輸卵管切除(雙側卵巢、雙側輸卵管))
OP site (雙側卵巢、雙側輸卵管)
OP will be performed on
Sign Consent Form (婦產科腹腔鏡手術-雙側卵巢輸卵管切除(雙側卵巢、雙側輸卵管))
.已簽自費特材同意書
NPO (Since midnight, except Micardis)
IVF (D5S run 80ml/hr, CM)
SKIN PREPARATION (at OR)
On Foley at OR (放置導尿管適應症：因手術需要)
Send patient to OR on call with chart,X-ray film
病人嚴重度分級:D級

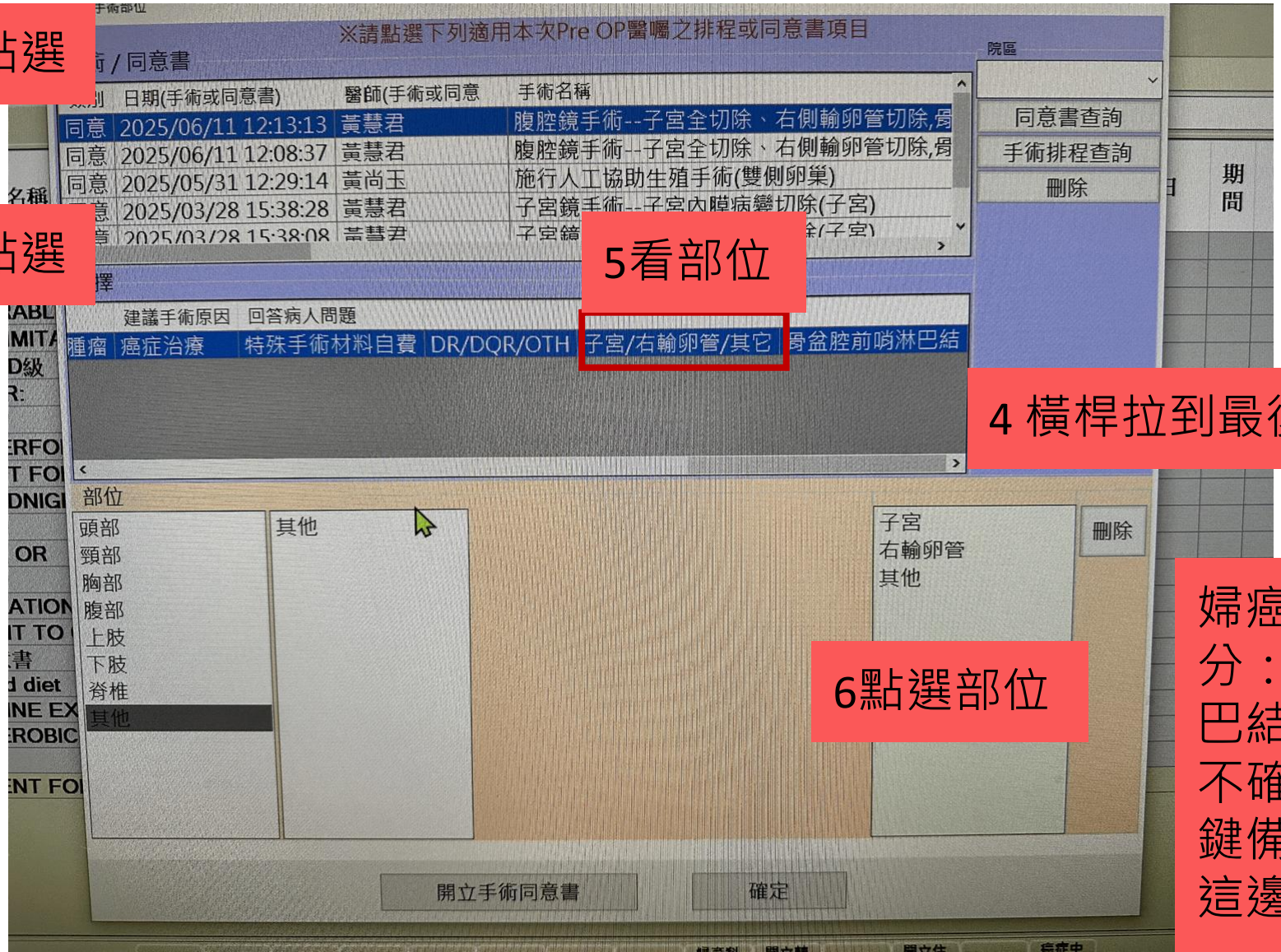

類別 藥品名稱 劑量 用法 服用
NEW Cefazolin sodium 1GM/vial 1PC ONCE
(to OR)
NEW Fleet enema 118mL/bot 1BT ONCE
(CM)
NEW Parecoxib 40mg/vial 1PC ONCE
(Before sent to OR(自費使用))
NEW Granisetron 3mg/3mL/Vial 1PC ONCE
((自費使用)to OR)

接新病人：婦癌手術

1 Key “sign consent form”自動進去介面

2 點選

3 點選



5看部位

4 橫桿拉到最後面

6點選部位

婦癌科會有一堆free-typing的手術部分：淋巴結, 骨盆淋巴結, 主動脈旁淋巴結, 闌尾, 大網膜, …etc.
不確定部位哪些算其他就算無法一鍵備刀
這邊提供大家查詢方法

林口婦產科工作規範

- LMYO: 腹腔鏡子宮肌瘤切除
- LAVH:腹腔鏡子宮切除
- LOVA:腹腔鏡卵巢輸卵管手術
- TCR: 子宮鏡手術

MA	手術方式	Fleet Enema	Dynastat Kytril	Terlipressin	Pyridium (Phenazo pyridine)	Cytotec (Misoprostol)	Bupivacaine 0.5% 20ml	Dexamethasone 5mg/1mL
		1pc CM	1PC IV (自費)	1pc IV to OR (自費)	1pc IRRE PO HS & CM (健保)	1pc IRRE PO HS & CM (自費)	1pc Loc to OR (自費)	4pc IV to OR (健保)
李奇龍	LMYO	V	V	V			V	V
	LAVH	V	V	V	V		V	V
	LOVA	V	V				V	V
	TCR		V			V		V
	癌症分期不需 Terlipressin, 3D 腹腔鏡需簽自費切結書 3 萬元							
顏志峰	LMYO		V			V CM		V
	LAVH		V		V 送刀前吃 1 顆	V CM		V
	LOVA		V					V
	TCR		V(看病人)			V		
	住院通知單無 CI/UA 可不另抽, **Hb 10.5 備 9.5 輸,** 3D 腹腔鏡需簽自費切結書 3 萬元 通常會自己在門診開好自費特材單							

接新病人：剖腹產

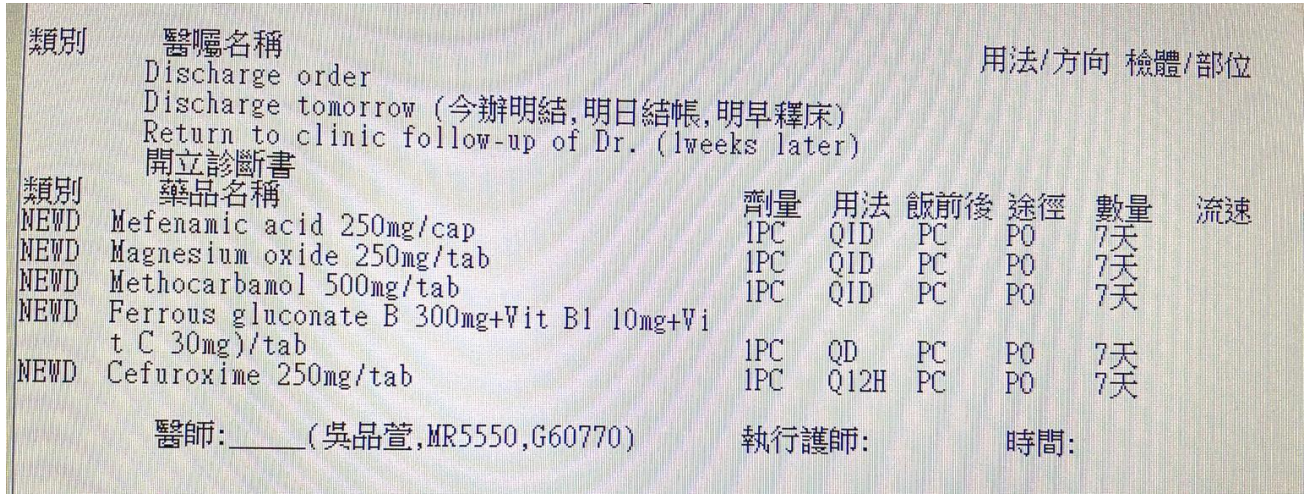
- 參考住院通知單
  - Lab 項目有圈起來代表已在住服中心抽過血
- 完成 Order + admission note + Pre-OP Note
  - 醫藥囑本科或他科範本 → 4720 產科範本 → A02-C/S → admission order
  - 幫助子宮收縮的藥物：Oxytocin(Piton-s) 2pc IVF to OR 或自費Carbetocin 1pc IV to OR擇一，請參考「林口婦產科工作規範」
  - 前置胎盤/其他術前Hb<8請備血LPR2U
  - IVF: LR 1000ml run 125ml/hr since CM, 若高血壓/雙胞胎改成run 80ml/hr
  - 自費特材：請參考「林口婦產科工作規範」

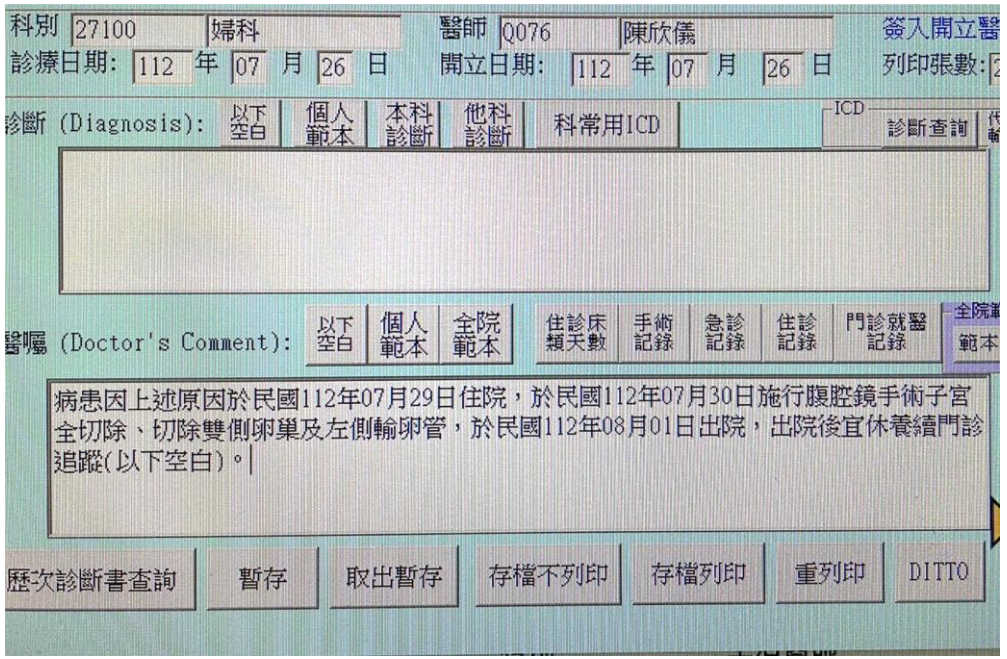
林口婦產科工作規範

	Enema CM	Carbetocin 1pc IV (to OR)	防沾黏	美皮蕾 只能開 1 片!
產科主治				
張舜智	X	V	Protahere	V
趙安祥	X	X	Seprafilm	X
闕河晏	X	X	Protahere	X
詹耀龍	X	Previa/Twin	Seprafilm Protahere (都可以, 但以 Seprafilm 為主)	V
彭秀慧	X	V	Protahere	V
李彥璋	X	V	Protahere	X 術後再使用
許晉婕	X	V	Protahere	X
江啟源	X	Previa/Twin	Barrigel 10ml	V

常用醫囑

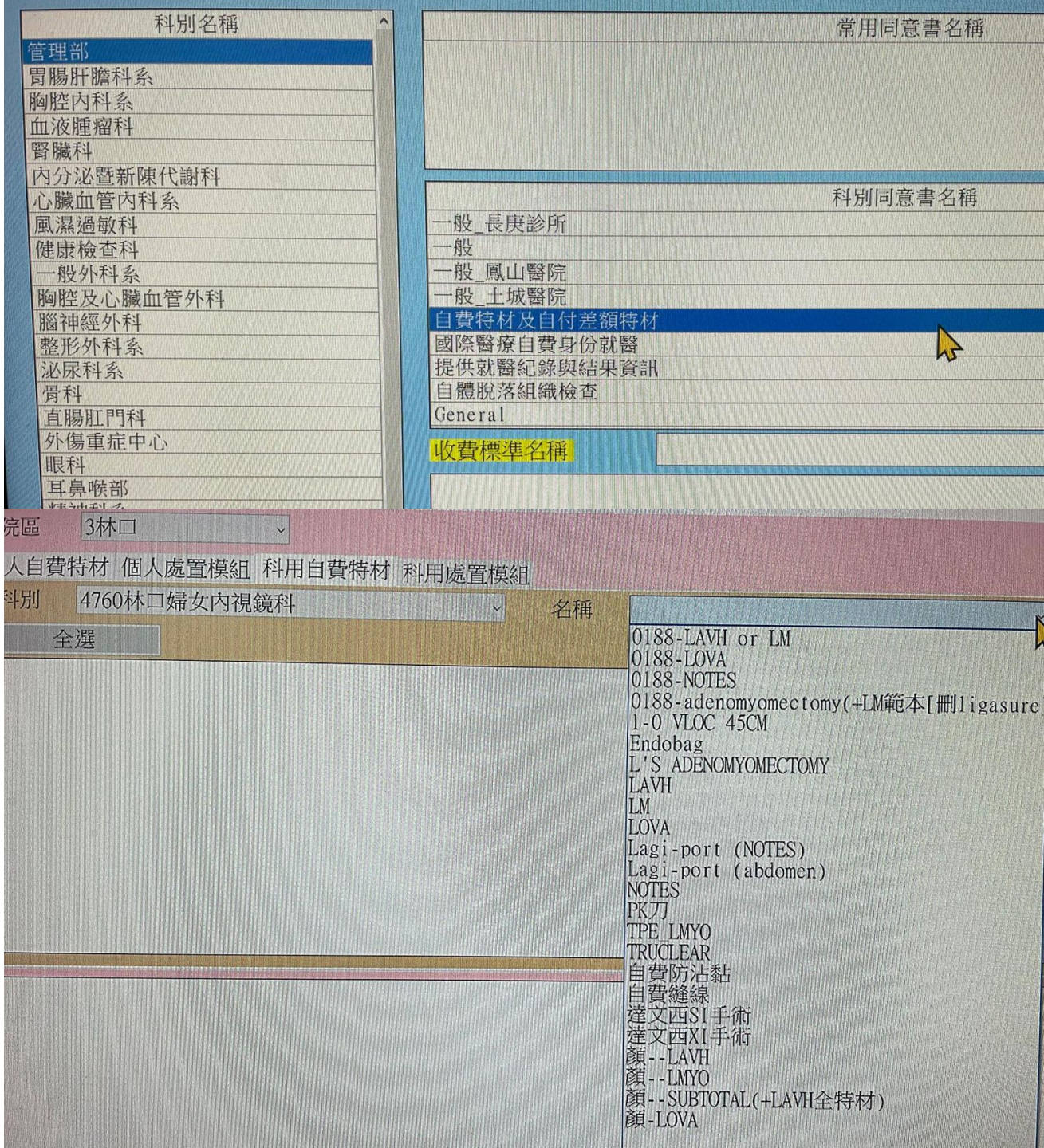
- CS 術後排氣 **order renew**：
  醫藥囑本科或他科範本 → **4720** 產科範本 → **A02-C/S** → **daily order**
  請參考「林口婦產科工作規範」
- 出院： **Discharge order** → **Discharge tomorrow** (今辦明結) → 回診→出院帶藥
- 診斷書：左邊功能選單→常用功能→開立診斷書





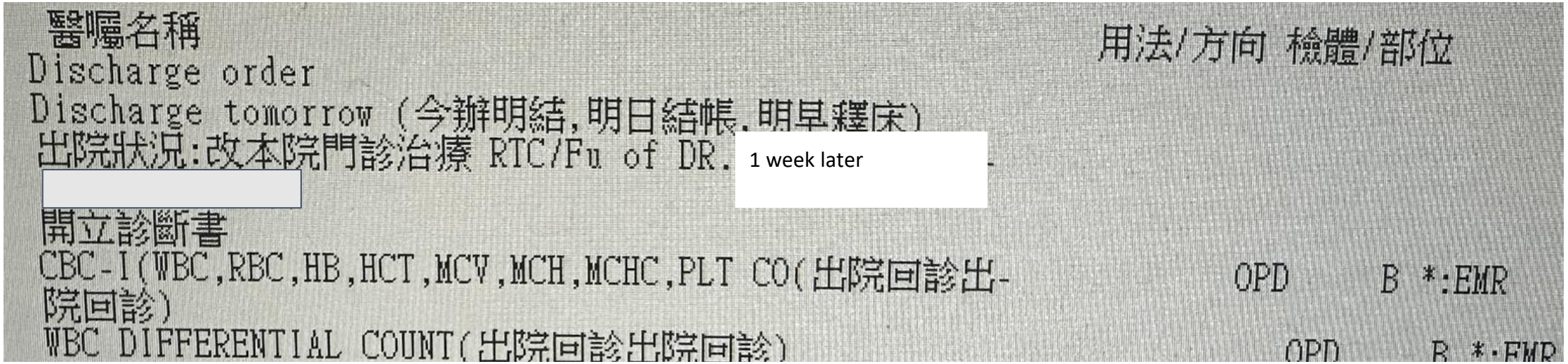
常用醫囑

- 自費特材: 病歷記載 → 同意書→ 同意書開立→查詢所有科別(左下) → 管理部(最上面) →自費特材及自付差額特材同意書→ 範本輸入→科用自費特材(4760 林口婦女內視鏡科)
- 病患自費切結: 住院醫囑→病歷記載→同意書→同意書開立→查詢所有科別→管理部→(拉到最下面)病患自費切結



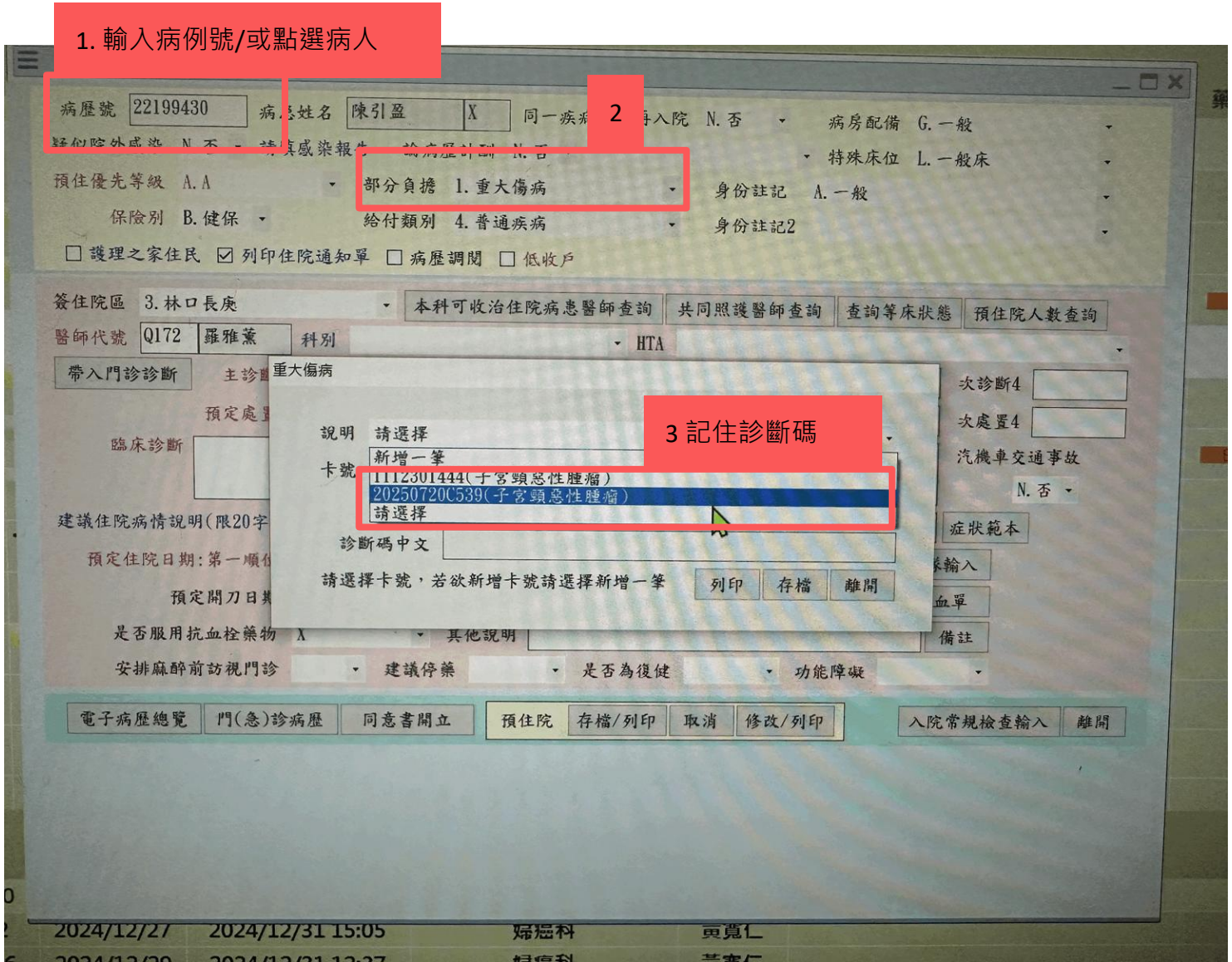
婦癌科出院

- 第一個**cycle** 的病人通常打完隔天出院
  第二個**cycle**以後可以詢問病人要不要打完當天出院
- 除了一般的出院**order** 之外，加上回診抽血**CBC/DC (**框框選**OPD)**、住院單

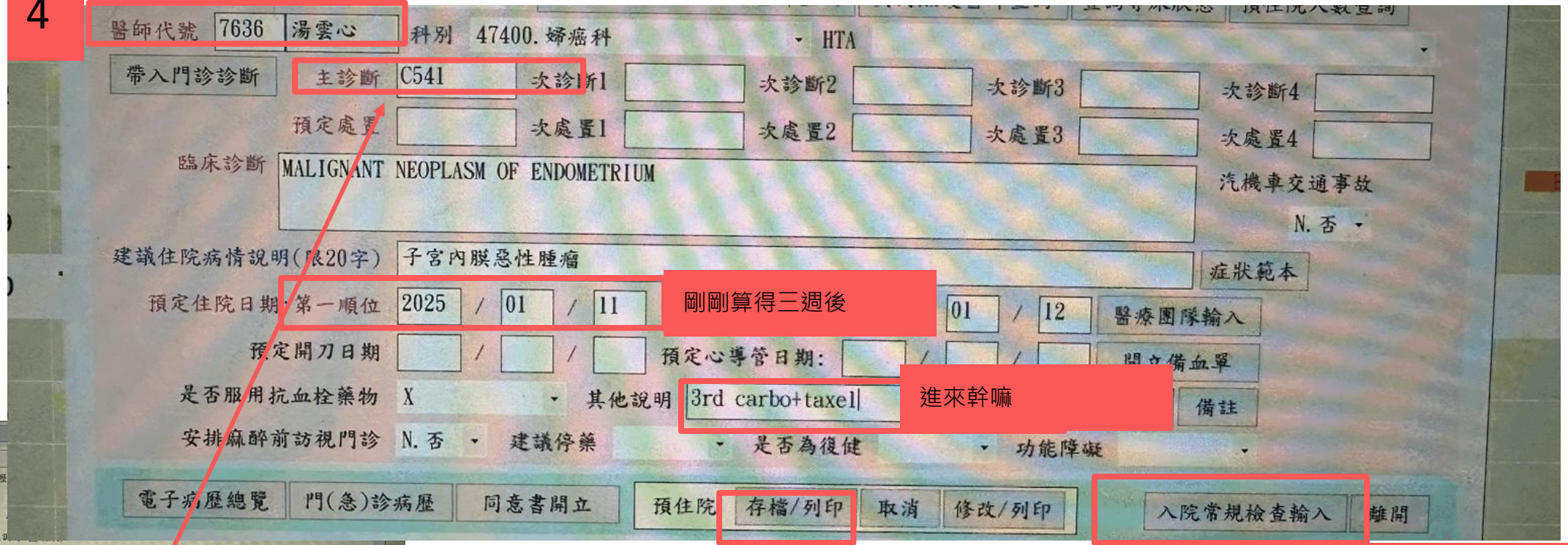


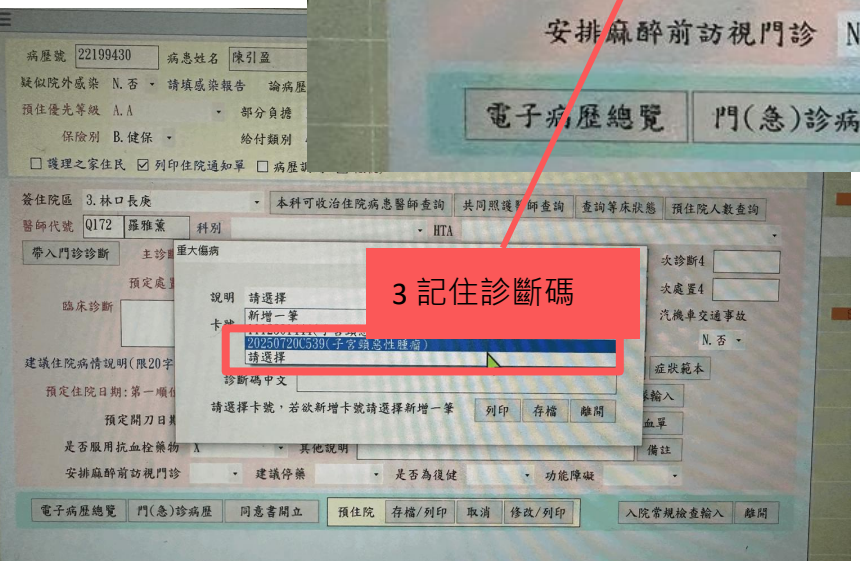
開立出院通知單:日期 **(**此次打**chemotherapy** 日期往後推三週**)**

婦癌科住院通知單


1. 輸入病例號/或點選病人
病歷號 22199430
陳引盈
2
部分負擔 1. 重大傷病
保險別 B. 健保
給付類別 4. 普通疾病
護理之家住民
列印住院通知單
病歷調閱
低收戶
簽住院區 3. 林口長庚
本科可收治住院病患醫師查詢
共同照護醫師查詢
查詢等床狀態
預住院人數查詢
醫師代號 Q172 羅雅薰
科別 HTA
帶入門診診斷
臨床診斷
重大傷病
說明 請選擇
3 記住診斷碼
卡號 新增一筆
20250720C539(子宮頸惡性腫瘤)
請選擇
診斷碼中文
請選擇卡號，若欲新增卡號請選擇新增一筆
列印
存檔
離開
是否服用抗血栓藥物
安排麻醉前訪視門診
建議停藥
是否為復健
功能障礙
電子病歷總覽
門(急)診病歷
同意書開立
預住院
存檔/列印
取消
修改/列印
入院常規檢查輸入
離開
2024/12/27
2024/12/31 15:05
婦癌科
黃覓仁

婦癌科住院通知單





CBC/DC, BUN, Crt, Na, K, AST, ALT,Urine routine/sediment

Tumor marker (之前有異常的)

病歷確實完成

- Admission note
- Progress note (每天 + 出院當天) / 住院一週的週五要有weekly summary
- Discharge summary

- 手術的病人:
  1. Pre-op (開刀前一天完成; 隔天住院開刀的病人跟Admission note 一起打!!!)
  2. Brief op (手術當天)
  3. Post-op note (手術當天完成，要用SOAP格式)

W5

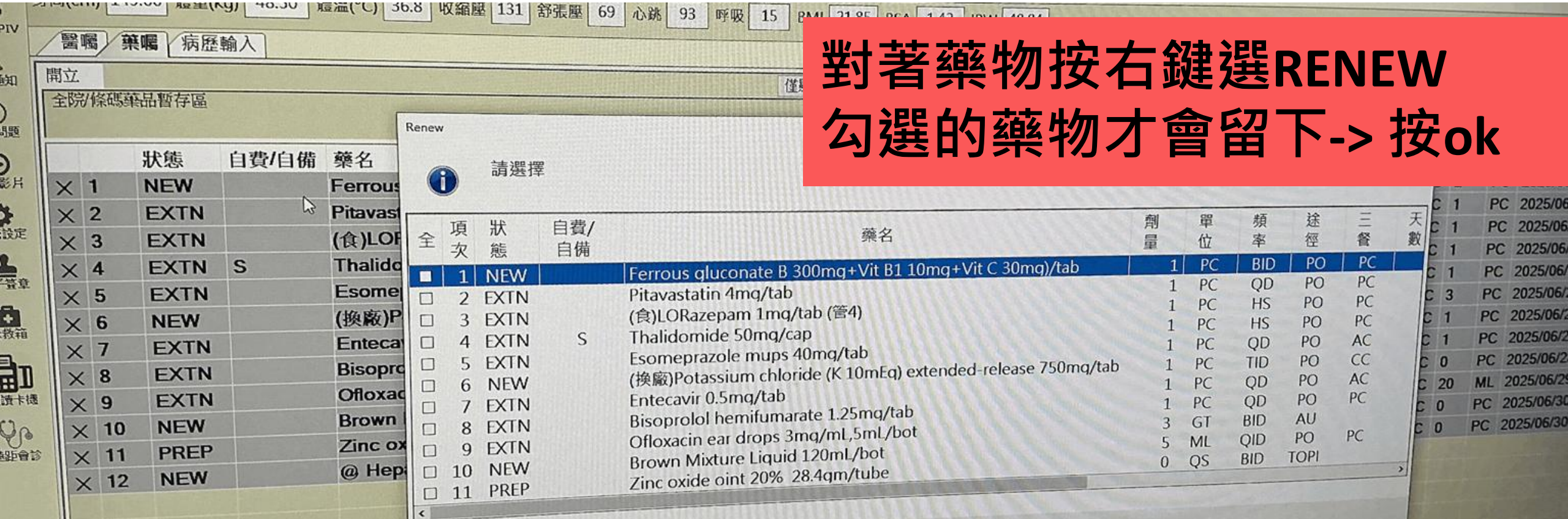
- 住有點久/並且會繼續住到下週的病人（尤其是婦癌科），檢視自己的病人用藥，有沒有不需要繼續使用的，並且renew “藥物”
(antibiotic 用多久了、lasix、其他症狀治療藥物是否還需要或者要調整？)

- 預先開好預計週日、週一出院的病人出院order（刪除今辦明結，改壓出院日期）

- 住超過7天的病人打weekly summary,其他寫progress note即可

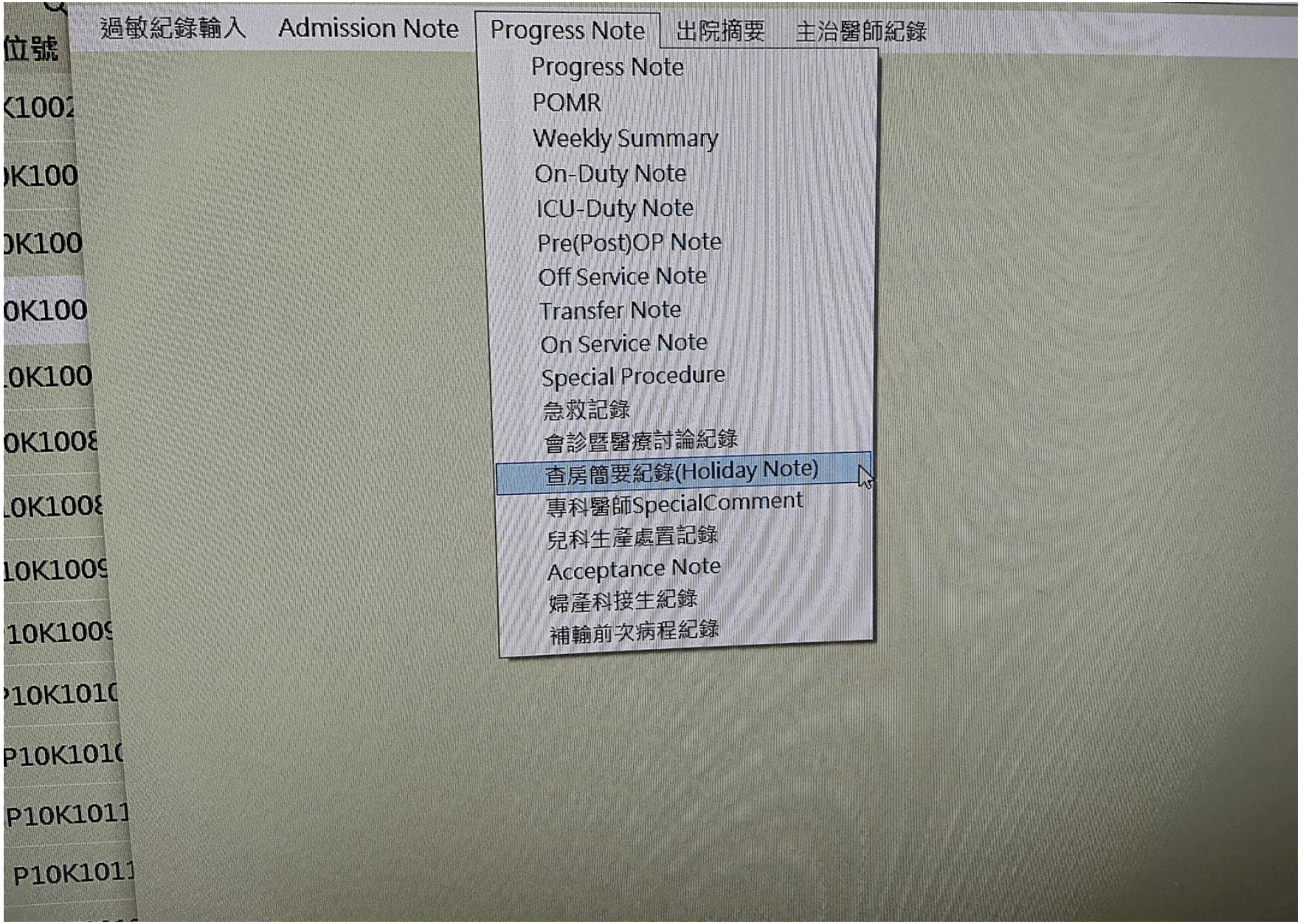
W5

- 住有點久/並且會繼續住到下週的病人（尤其是婦癌科），檢視自己的病人用藥，有沒有不需要繼續使用的，並且**renew “藥物”**
  (antibiotic 用多久了、lasix、其他症狀治療藥物是否還需要或者要調整？)



週末值班

- 上班第一件事情把病房**holiday note**點掉,大家週一都不用補**progress**
- 進去按存檔就好



Admission note

- CC:
  - menorrhagia/dysmenorrhea/lower abdominal pain/urinary frequency… for ___ months/years
  - 請勿打admitted for surgery!!
- PI:
  - This __-year-old female is G_P_A_, LMP:__ /menopaused at __y/o, with underlying disease of__ / without underlying disease.
    She was suffered from_____, accompanied with ___. She denied _____. Therefore, she came to Dr.____'s OPD for help. At OPD, examination showed____…. Under the impression of ____, she was admitted to our ward for schedule surgery _____.
- Past history: 慢性疾病、Operation history (尤其腹腔的手術!)
- Impression: 請勿直接使用ICD診斷碼!!

Terminology

- Gravidity: 懷孕次數
- Parity: 妊娠20週之後分娩次數(不論死活或雙胞胎)，如果生過，請括號寫上SD/CS，例如：P1(SD)或是P2(CS*2)或是P3(SD*2,CS*1)
- Abortus: 妊娠20週之前分娩 (SA or AA)
- Ectopic
- Sexual exposure? 沒有懷孕過(G0)的病人要問，標註G0, sex(+) / G0, sex(-)
- LMP - last menstrual period (first day of)

- 懷孕幾次? 生幾個小孩 ? 自然生還是剖腹產? 有流產或墮胎過嗎?
- 最後一次月經的第一天是哪天? 幾歲的時候停經?
- 肚子有開過刀嗎?之前傷口是開直的還是橫的?

Test!

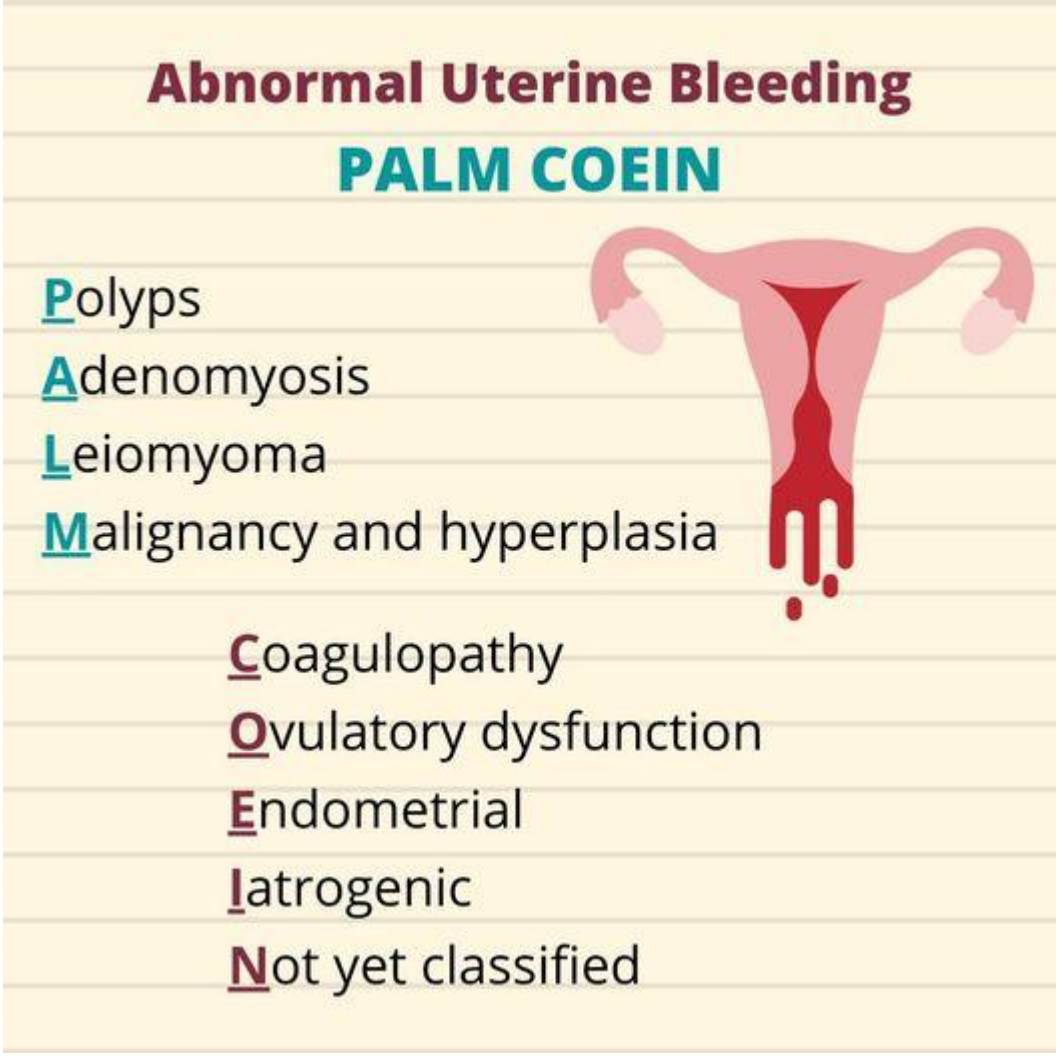
- 生過三個孩子，其中兩個是雙胞胎，雙胞胎那次是CS，還有一次8週沒有胎心音，以及人工流產1次(6週)

- 生過1個，另外有一個21週自然流產

- 之前因胎位不正剖腹產生過1個孩子，人工流產1次，目前懷孕36週，入院剖腹產

Terminology

- Abnormal uterine bleeding(AUB)
- Menorrhagia/Hypermenorrhea /Heavy menstrual bleeding(HMB)
- Post-menopausal bleeding (PMB)
- Dysmenorrhea
- Oligomenorrhea
- Intermenstrual bleeding



Admission note

主訴:(Chief Complaint)

Abdominal distend for 1 year

現在病症:(Present Illness)

This 46-year-old female patient, G1P1(C/S due to induction failure in 2010), LMP: 2023/06/18, denied any systemic underlying disease.

She has suffered from abdominal distend since 2022/05. The symptom also associated with enlarged abdominal circumference in recent 2 months. She denied menorrhagia, vaginal spotting, poor appetite, nausea, vomiting, body weight loss, urinary frequency, constipation or other specific symptoms. Under the above discomfort, she visited our OPD for further evaluation and treatment.

In our OPD, PV showed cervical smooth. Elevated CA199: 73.3U/mL was noted. Transvaginal sonography revealed right ovairan cystic mass 15.59*11.76cm with solid part, no flow, which was suspected malignancy. Abdominal MRI showed huge complex cystic tumor in the right adnexal region, ovarian malignancy
arising from the right ovary is highly considered. Both panendoscopy and colonscopy showed negtive finding. Under the impression of right adnexal complex cystic tumor can't rule out malignancy, she is admitted for laparoscopic right salpingo-oophorectomy (Frozen) and possible deculking surgery, if Fronzen showed malignancy tomorrow.

婦產科常見疾病/診斷

產科

- Vaginal delivery(NSD/SD) 自然生產
  1. Pregnancy at ___ weeks of gestation
  2. Vaginal delivery on 2024/08/19 with __ degree perineal laceration
- Cesarean section(CS) 剖腹生產 適應症!!!
  1. Pregnancy at ___ weeks of gestation
  2. Cesarean section on 2024/08/19 due to ___(breech presentation, previous CS, twin pregnancy, pre-myomectomy, fetal distress, second arrest...)
- Tocolysis 安胎

婦産科常見疾病/診斷

婦科

- Laparoscopy: uterine myoma, ovarian tumor, adenomyosis
- Urology: urinary incontinence尿失禁, pelvic organ prolapse脫垂
- Oncology: endometrial cancer, ovarian cancer, cervical cancer
- Infertility: ovarian hyper-stimulation syndrome(OHSS), endometriosis, tubal occlusion

Abbreviation of operation

- Hysterectomy
  - ATH – Abdominal Total hysterectomy (Laparotomy)
  - VTH – Vaginal total hysterectomy
  - LAVH –Laparoscopic Assisted Vaginal Hysterectomy (L's)
  - LASH – Laparoscopic-assisted supracervical hysterectomy
  - LSH – Laparoscopic subtotal hysterectomy
- Salpingo-Oophorectomy (SO)
  - Salpingectomy / Salpingostomy
  - Oophorectomy / Cystectomy / Enucleation
  - LOVA / L's enucleation
- LESS – Laparoendoscopic single-site surgery
- NOTES – Natural orifice transluminal endoscopic surgery

Pre-OP note

隔天住院開刀的病人跟Admission note 一起打!!!

- Brief history: Age, GP, LMP, Chief complaint
- Systemic disease / Operative history
- Physical examination(門診紀錄)
- Image, Sonography: (或其他特殊檢查 ex: CT，MRI)
- Pre-op diagnosis (Indication)
- Lab: (tumor marker?)
- CXR/ EKG
- OP method/ OP date
- Anesthesia method:
- ASA scores & mortality rates:
- Informed consent

Progress Note 紀錄者:陳欣儀　主治醫師:高川琪

```
2023/07/16   14:12
<<Pre-Op Note>>

<Brief History>
52y/o, G3P2(C/S P1 C/S due to severe pre-eclampsia, P2 C/S due to previous C
and Type 2 diabetes mellitus under medication treatment. pap test 41.0g

CC: progreessive urinary leakage for 1 year

<Pre-OP Diagnosis>
1. Urinary stress incontinence, pap test 41.0g
2. Essential hypertension under medication treatment
3. Type 2 diabates mellitus under medication treatment

<OP Indication>
progressive urinary leakage with dysuria, noctuira and urinary urgency

<OP Method>
midurethral sling (I-stop mini)

<OP Site>
vagina

<OP Date>
2023/07/17

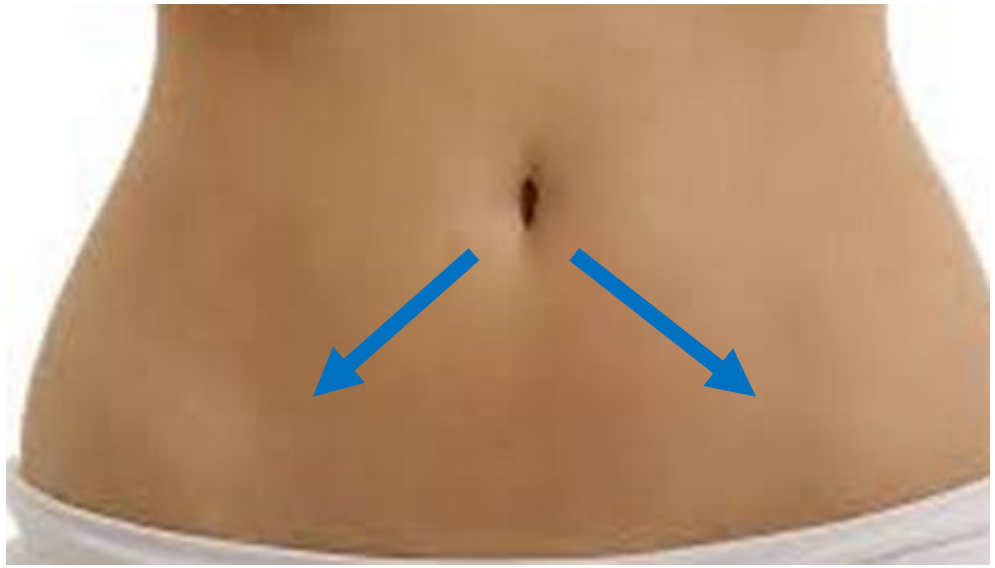
<Pre-OP Evaluation>
2023/07/16 EKG:normal sinus rhythm
2023/07/16 CXR:no obvious pneumonia pattern
2023/05/09 Pelvic examination
Cystocele grade2, Uterine prolapse gradel, Rectocele gradel
2023/05/16 Urodynamic study examination
Urodynamic stress incontinence and intrinsic detrusor deficiency with pad te

(血液):
(生化):
pending

Anesthesia method: general oral-tube
ASA Class II

<Alternative treatment>
   passery but patient refused
*We have explained the risks and indications of the surgery to the patient a
the consent form for the operation.
```

手術部位標示



標示劃刀部位: 以肚臍為中心指向手術部位
如手術同意書上寫要開「患側」則可以不用標左右邊

Thank you